하루차림

암 치료 중 식사 이야기

가려 드시기 전에

치료가 시작되면 식탁에서 하나둘 빠지는 음식이 생깁니다. 대부분 걱정과 정성에서 나온 일입니다. 그런데 그렇게 줄어든 한 숟가락이 쌓이면, **치료를 견딜 힘도 함께 줄어듭니다.** 연구가 말하는 것과 아직 말하지 않는 것을 나누어 정리했습니다.

> 20년 넘게 암 환자를 치료해 온 방사선종양학과 전문의가 내용을 감수했습니다.

1 진료 시간에 다 듣기 어려웠던 이야기

2 주위에서 전해 들은 이야기

3 그 사이에 생기는 영양 부족

4 음식 하나하나를 살핀 자료

5 근거로 차리는 한 상

1 진료 시간에 다 듣기 어려웠던 이야기

얼마나 드시는지는, 진료실에서 잘 보이지 않습니다

진료 시간은 짧고, 그 시간에는 검사 결과와 치료 일정을 먼저 이야기하게 됩니다. "무엇을 피해야 하나요?"는 여쭤보셔도, "요즘 하루에 얼마나 드세요?"까지 오가기는 어렵습니다. 그런데 식사는 치료가 시작되기 전부터 이미 흔들리고 있는 경우가 많습니다.

51%

이탈리아 22개 병원에서 처음 항암 진료를 받으러 온 환자 1,952명 가운데, 이미 영양 상태에 문제가 있거나 그 위험이 있던 분의 비율.[1]

64%

같은 환자들 가운데 진료 전 6개월 동안 체중이 1~10 kg 줄어 있던 분. 치료를 시작하기도 전입니다.[1]

프랑스 전국 조사에서는 의사들이 환자의 식사량을 실제보다 많게 짐작했고, 나이 드신 환자에서 특히 그랬습니다.[2] 진료실에서는 잘 드시는 것처럼 보여도, 집 식탁은 다를 수 있다는 뜻입니다.

그래서 먼저 말씀드리고 싶은 세 가지

체중은 치료 경과의 일부입니다

6개월 안에 체중이 5 % 넘게 줄면(60 kg이면 3 kg) 담당 의료진께 알려야 할 신호입니다. 영양불량을 진단하는 국제 기준이 쓰는 문턱입니다.[3]

단백질은 오히려 더 필요합니다

치료 중에는 체중 1 kg당 하루 1~1.5 g을 권합니다. 60 kg이면 60~90 g입니다.[4]

따로 정해 받은 제한이 없다면, 가리기보다 드시는 것이 먼저입니다

담당 의료진이 정해 준 식사 제한(저요오드식, 수술 뒤 식사 단계 등)은 꼭 지키시고, 그 밖의 음식은 스스로 끊기 전에 한 번 더 확인해 주세요.

2 주위에서 전해 들은 이야기

걱정에서 나온 말이, 식탁을 좁힙니다

먼저 치료받은 친척, 같은 병실 환자분, 인터넷 카페에서 전해 들은 이야기는 대개 정성에서 나옵니다. 다만 그 말들이 하나둘 겹치면, 드실 수 있는 음식이 생각보다 빠르게 줄어듭니다.

78.2%

국내 온라인 암 환우 모임 응답자 221명 가운데 보완·대체요법을 써 본 분. 그중 주치의와 상의한 분은 30.6 %였습니다.[5]

32.5%

미국 SNS에서 많이 공유된 암 치료 글 200건 가운데 잘못된 정보가 담긴 글. 해로울 수 있는 글이 반응을 더 많이 받았습니다.[6]

86%

홍콩의 암 환자 245명 가운데 음식을 가리는 분. 많이 가릴수록 단백질·아연·철을 적게 드셨습니다.[7]

그 가운데 자주 듣는 이야기 다섯 가지를 원문으로 확인했습니다.

"암 환자는 고기를 끊어야 한대요."

고기·유제품을 통째로 끊을 근거는 없습니다.

진단 뒤 식사를 다룬 전향 연구 29편을 모은 분석은 어떤 식품군도 없앨 필요는 없다고 결론지었습니다. 줄이실 것은 햄·소시지 같은 가공육이고, 단백질은 오히려 넉넉히 드셔야 합니다.[8,4]

"유방암이면 두부·된장·두유를 끊어야 한대요."

끊지 않으셔도 됩니다.

유방암 환자 9,514명 연구에서 콩 이소플라본을 하루 10 mg 이상 드신 분들의 재발이 25 % 낮았습니다. 농축 보충제는 따로 봅니다.[9]

"항암 중에는 생과일·생채소를 먹으면 안 된대요."

잘 씻어 드시면 됩니다. 새싹채소만은 익혀 드세요.

가려 먹는 식단이 감염을 줄인다는 근거는 6편·1,114명 분석에서 확인되지 않았습니다. 담당 의료진이 따로 정해 준 기준이 있으면 그것을 먼저 따르세요.[10]

"설탕이 암을 키우니 단 것은 다 끊어야 한대요."

끊는다고 암이 굶는다는 연구는 없습니다. 다만 단 음료는 줄이세요.

설탕을 끊은 환자의 결과를 본 시험은 찾지 못했습니다. 한편 3기 대장암 1,011명 관찰에서 가당 음료를 하루 2잔 넘게 마신 분은 재발·사망 위험이 높았습니다(1.67배). 밥과 과일까지 끊을 일은 아닙니다.[11]

"굶으면 암도 굶는대요."

혼자 시작하는 단식은 권하지 않습니다.

프랑스 생존자 2,741명 가운데 6.0 %가 단식을 해 보았고, 예후가 좋아질 거라는 믿음과 관련이 있었습니다. 의료진에게 영양 정보를 받은 분은 단식을 덜 했습니다. 단식은 지금 의료진이 관리하는 시험 안에서 연구되는 단계이고, 그 시험도 마른 분과 당뇨가 있는 분은 받지 않았습니다.[12,13]

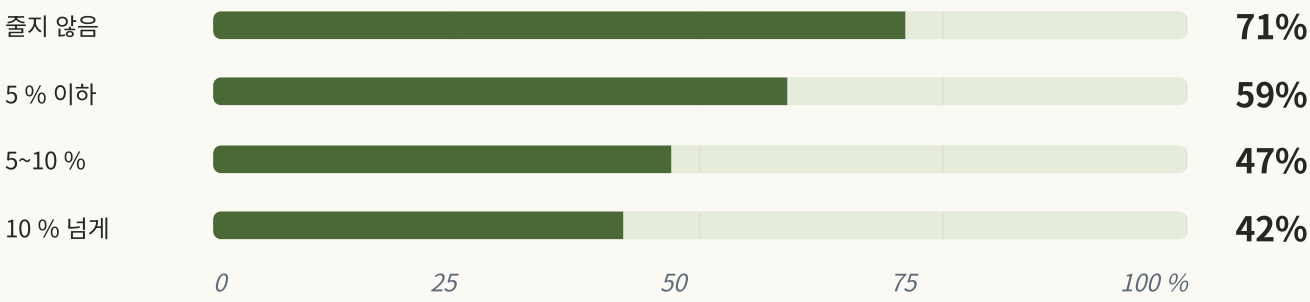
3 그 사이에 생기는 영양 부족

체중이 줄면, 치료를 견디기가 어려워집니다

꼭 필요한 제한 하나도 식탁 전체를 줄입니다. 서울대병원에서 갑상선암 환자 92명이 방사성 요오드 치료를 앞두고 저요오드식을 하는 동안, 하루 열량이 평소보다 **446 kcal** 적었습니다.[14] 꼭 필요해서 하는 제한도 이렇습니다. 그래서 제한은 필요한 만큼, 필요한 기간만 하는 것이 좋습니다.

방사선치료 전 체중이 줄어든 정도와 5년 생존율

두경부암으로 방사선치료를 받은 1,340명, 네덜란드[15]



나이·병기 같은 다른 요인을 맞춘 뒤에도, 치료 전 10 % 넘게 줄었던 분의 사망 위험은 1.7배였습니다. 치료 중에 체중이 크게 준 경우도 결과가 나빴습니다.

부작용은 늘고, 받은 치료는 줄었습니다

위장관암으로 항암치료를 받은 1,555명에서, 체중이 줄어 있던 분은 손발 피부 반응과 입안 염증이 더 잦고 심했습니다. 치료는 평균 한 달(18 %) 덜 받으셨습니다. 연구진은 결과가 나빴던 까닭을 약이 덜 들어서가 아니라, 치료를 덜 받고 부작용이 많았던 데서 찾았습니다.[16]

많이 줄고 마를수록, 생존 기간이 짧았습니다

캐나다·유럽 8,160명에서 체중 감소와 마른 정도를 함께 본 등급에 따라 생존 기간 중앙값이 20.9개월부터 4.3개월까지 벌어졌습니다.[17]

근육은 체중계에 바로 드러나지 않습니다

38편·7,843명을 모은 분석에서 CT로 잰 근육량이 적은 분은 사망 위험이 1.44배였습니다.[18] 단백질을 챙기는 이유입니다.

연구가 아직 말하지 않는 것

- 위 연구는 모두 **관찰 연구**입니다. 체중이 줄어서 결과가 나빴는지, 병이 깊어서 체중이 줄었는지를 완전히 가를 수는 없습니다.
- 영양 상담과 보충은 식사량·체중·삶의 질을 지키는 데 도움이 되었습니다. 그러나 13개 시험·1,414명을 모은 분석에서 **생존을 늘렸다는 결과는 나오지 않았습니다**(사망 위험 1.06배, 차이 없음).[19]
- 그래서 하루차림은 "잘 드시면 오래 사신다"고 말하지 않습니다. 치료를 끝까지 받으실 수 있도록 몸을 지키는 일로 봅니다.

4 음식 하나하나를 살핀 자료

같은 음식도, 누가 드시느냐에 따라 답이 다릅니다

'좋은 음식·나쁜 음식' 목록은 편하지만, 한 가지 답으로는 모든 분께 맞출 수 없습니다. 그래서 음식마다 성분을 따로 쌓고, 암 종류·치료 시기·증상·드시는 약에 따라 판단을 나누었습니다.

광어(회)	호중구가 낮은 시기	피하세요	치료를 마친 뒤	권함
새우젓	위암	피하세요	유방암	주의
청국장	와파린 복용 중	주의	복용약 없음	권함

291,378
음식·식품
기본 음식 18,298 + 시판 가공식품 273,080. 영양성분은 국가표준식품성분표와 제품 표시값

50,524
건강기능식품
국내 45,618 + 수입 4,906. 원료마다 암 종류·복용약에 따라 따로 판단

4,695
의약품 이름
영양제로 착각하기 쉬운 의약품은 판정하지 않고 "의약품입니다"라고 알려 드림

158
판단 규칙
음식 130 + 약물–음식 상호작용 28. 규칙마다 근거 등급

172
참고 문헌
요약이 아니라 원문을 받아 앱 문장과 한 줄씩 대조

177,971
알레르기 원재료
알레르기 19종을 원재료 표시와 대조

영양 목표는 2025 한국인 영양소 섭취기준과 유럽임상영양대사학회(ESPEN) 암 영양 지침을 따릅니다. 판단의 근거가 된 문헌은 앱 안에서 항목마다 열어 보실 수 있습니다.

5 근거로 차리는 한 상

빼는 목록이 아니라, 채우는 상차림

하루차림은 무엇을 피할지만 알려 드리지 않습니다. 체중과 치료 시기에 맞춰 하루 목표를 정하고, 밥을 먼저 앉힌 뒤 반찬과 국을 더해 한국식 한 상을 차립니다. 앞에서 본 근거가 화면에서는 이렇게 쓰입니다.

체중에 맞춘 하루 목표

키·체중·치료 시기로 하루 열량과 단백질 목표를 셈합니다. 단백질은 체중 1 kg당 1~1.5 g을 기준으로 잡습니다.[4]

체중이 줄면, 먼저 채웁니다

6개월 안에 5 % 넘게 줄면 알려 드립니다. 입안이 헐거나 설사·메스꺼움 때문에 '피하세요'로 두었던 음식 일부는 '주의'로 낮춥니다. 지금은 드실 수 있는 것을 드셔서 열량과 단백질을 채우는 것이 먼저이기 때문입니다.[3,4]

모자란 날을 짚어 드립니다

하루치 평균만 보지 않고, 일주일 가운데 며칠이나 열량·단백질이 모자랐는지 함께 보여 드립니다.

왜 권하는지까지

반찬마다 근거 등급(A·B·C·G)과 출처가 붙습니다. 근거가 없는 것은 "아직 모릅니다"라고 적습니다.



일주일 기록에서 모자란 것을 짚어 드립니다(예시 화면)



반찬마다 왜 권하는지와 근거 등급이 붙습니다(예시 화면)

오늘 한 상부터 차려 보세요

암 종류·치료 시기·드시는 약을 넣으면 하루 세 끼 한식 상차림을 추천합니다. 치료를 대신하지 않으며, 모든 안내는 "담당 의료진과 상의하세요"로 끝납니다. 기록은 기기 안에 저장됩니다.

하루차림은 의료기기가 아니며 진단·치료를 목적으로 하지 않습니다. 이 페이지는 일반 정보이며, 개인의 치료와 식사는 담당 의료진과 정하십시오. 만 14세 이상 이용할 수 있습니다.

근거 목록

논문 수치는 모두 PubMed 초록 원문과 대조했습니다(2026년 11월 9일). 앱 숫자는 같은 날 앱 자료에서 셈한 값입니다.

1. Muscaritoli M, et al. Prevalence of malnutrition in patients at first medical oncology visit: the PreMiO study. Oncotarget. 2017;8:79884-96. PMID 29108370. doi:10.18632/oncotarget.20168
2. Lacau St Guily J, et al. NutriCancer: malnutrition in elderly patients with cancer. J Geriatr Oncol. 2018;9:74-80. PMID 28888553. doi:10.1016/j.jgo.2017.08.003
3. Cederholm T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019;10:207-17. PMID 30920778. doi:10.1002/jcsm.12383
4. Muscaritoli M, et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40:2898-913. PMID 33946039. doi:10.1016/j.clnu.2021.02.005
5. Kim JS, et al. Complementary and alternative medicine among patients with cancer in Korea (KCSG PC21-20). Cancer Res Treat. 2023;55:442-51. PMID 36596728. doi:10.4143/crt.2022.1483
6. Johnson SB, et al. Cancer misinformation and harmful information on Facebook and other social media. J Natl Cancer Inst. 2022;114:1036-9. PMID 34291289. doi:10.1093/jnci/djab141
7. Yung TKC, et al. Protein food avoidance behaviour among cancer patients. Asia Pac J Clin Nutr. 2022;31:191-200. PMID 35766554. doi:10.6133/apjcn.202206_31(2).0004
8. Rinninella E, et al. The facts about food after cancer diagnosis: a systematic review of prospective cohort studies. Nutrients. 2020;12:2345. PMID 32764484. doi:10.3390/nu12082345
9. Nechuta SJ, et al. Soy food intake after diagnosis of breast cancer and survival. Am J Clin Nutr. 2012;96:123-32. PMID 22648714. doi:10.3945/ajcn.112.035972
10. Ma Y, et al. Neutropenic diet cannot reduce the risk of infection and mortality in oncology patients with neutropenia. Front Oncol. 2022;12:836371. PMID 35356218. doi:10.3389/fonc.2022.836371
11. Fuchs MA, et al. Sugar-sweetened beverage intake and cancer recurrence and survival in CALGB 89803. PLoS One. 2014;9:e99816. PMID 24937507. doi:10.1371/journal.pone.0099816
12. Fassier P, et al. Fasting and weight-loss restrictive diet practices among 2,700 cancer survivors (NutriNet-Santé). Int J Cancer. 2018;143:2687-97. PMID 29971783. doi:10.1002/ijc.31646
13. de Groot S, et al. Fasting mimicking diet as an adjunct to neoadjuvant chemotherapy for breast cancer (DIRECT). Nat Commun. 2020;11:3083. PMID 32576828. doi:10.1038/s41467-020-16138-3
14. Ju DL, et al. Dietary evaluation of a low-iodine diet in Korean thyroid cancer patients. Nutr Res Pract. 2016;10:167-74. PMID 27087900. doi:10.4162/nrp.2016.10.2.167
15. Langius JAE, et al. Critical weight loss is a major prognostic indicator for disease-specific survival in head and neck cancer receiving radiotherapy. Br J Cancer. 2013;109:1093-9. PMID 23928661. doi:10.1038/bjc.2013.458
16. Andreyev HJ, et al. Why do patients with weight loss have a worse outcome when undergoing chemotherapy for gastrointestinal malignancies? Eur J Cancer. 1998;34:503-9. PMID 9713300. doi:10.1016/s0959-8049(97)10090-9
17. Martin L, et al. Diagnostic criteria for the classification of cancer-associated weight loss. J Clin Oncol. 2015;33:90-9. PMID 25422490. doi:10.1200/JCO.2014.56.1894
18. Shachar SS, et al. Prognostic value of sarcopenia in adults with solid tumours: a meta-analysis. Eur J Cancer. 2016;57:58-67. PMID 26882087. doi:10.1016/j.ejca.2015.12.030
19. Baldwin C, et al. Oral nutritional interventions in malnourished patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2012;104:371-85. PMID 22345712. doi:10.1093/jnci/djr556